

RELATÓRIO TÉCNICO — AVALIAÇÃO COM USUÁRIO

Teste de Usabilidade com Usuários Reais

Portal Sabin Diagnóstico e Saúde — *sabin.com.br*

Preparado por	Equipe IHC 2026.1 — Grupo 07
Instituição	Universidade de Brasília (UnB)
Método	Think Aloud + System Usability Scale (SUS)
Referência	Tarefa Tg_IHC-03
Data	Junho de 2026
Versão	1.0

Sumário

- 1. Introdução
- 2. Perfil do Usuário-Alvo
- 3. Roteiro de Tarefas
- 4. Procedimento, Ambiente e Ética (TCLE)
- 5. Métricas de Usabilidade
- 6. Escore SUS (System Usability Scale)
- 7. Achados de Usabilidade
- 8. Achados de Acessibilidade (WCAG 2.2)
- 9. Recomendações Priorizadas
- 10. Reflexão Final
- 11. Referências
- 12. Anexos

1. Introdução

Este relatório documenta o **teste de usabilidade empírico** conduzido pelo Grupo 07 da disciplina de Interação Humano-Computador (IHC 2026.1, UnB) sobre o **portal Sabin Diagnóstico e Saúde** (sabin.com.br), um site real e público de uma das maiores redes de medicina diagnóstica do Brasil. O objetivo é avaliar empiricamente a qualidade de uso do portal nas tarefas centrais do paciente — **agendar exames, agendar vacinas e localizar orientações de preparo** — observando usuários reais em ação.

O estudo articula métodos consagrados de IHC: o protocolo **Think Aloud** (verbalização simultânea) de Nielsen (1993) para coleta qualitativa, e o instrumento validado **System Usability Scale (SUS)** de Brooke (1996) para mensuração da satisfação. As métricas de eficácia, eficiência e erros seguem a abordagem de Rubin & Chisnell (2008). A tarefa exigia ao menos **um usuário real**; o grupo conduziu sessões com **três participantes** (P1, P2 e P3), ampliando a base de observação.

3

USUÁRIOS REAIS

37,5

SUS MÉDIO
(INACEITÁVEL)

83%

EFICÁCIA NA T1

3

PROBLEMAS
CRÍTICOS/ALTOS

Síntese: mesmo com participantes de alto letramento digital, o fluxo de agendamento revelou-se confuso. O termo *"Compra online"* não é reconhecido como "agendar exame", o botão "Agendar" desvia o usuário para o atendimento domiciliar sem aviso, e não há etapa de escolha de data. O resultado é um **SUS médio de 37,5** (faixa "Inaceitável"). Em contraste, a tarefa de consultar o preparo de check-up (T3) foi resolvida sem dificuldade — confirmando que o problema está **concentrado no fluxo de agendamento**, não no site como um todo.

2. Perfil do Usuário-Alvo

O público real do portal Sabin é amplo (pacientes de todas as idades, cuidadores, usuários de convênio). Para esta rodada, definiu-se uma **persona primária** e critérios objetivos de recrutamento, conforme orienta Krug (2014) ao recomendar a descrição sucinta do usuário real do produto.

2.1 Persona primária — "Ana"

Atributo	Descrição
Nome / idade	Ana, 20 anos — <i>"Eu sei usar tecnologia, só quero que o site não me faça perder tempo"</i>
Ocupação	Estudante de Engenharia de Software (ensino superior em curso)
Dispositivo principal	Smartphone, com uso eventual de notebook
Uso de internet	Diário e intenso (estudo, redes sociais, apps de serviço)
Letramento digital	Alto — usuária avançada, rápida em identificar padrões de interface
Contexto de uso	Quer agendar exames sem telefonar, conferir preparo e acessar resultados online
Frustrações	Pouca paciência para fluxos longos; abandona e liga para a central se travar por 1–2 min

2.2 Participantes recrutados

Foram recrutados **3 participantes reais** que se encaixam na persona, nenhum deles colega da disciplina nem envolvido na elaboração do roteiro. Critérios de exclusão aplicados: vínculo com o Sabin ou concorrente; experiência profissional em UX/Design; condução prévia de testes de usabilidade.

Participante	Perfil	Relação com o Sabin
P1	20 anos, estudante de Eng. de Software, alto letramento digital	Já fez exames presencialmente; nunca agendou pelo site
P2	19 anos, estudante de Eng. de Software, usa celular como dispositivo principal	Já fez exames na unidade Ceilândia Centro
P3	20 anos, estudante de Eng. de Software (feminino), uso diário de internet	Conhece o Sabin; uso pouco frequente do site

Limitação de amostra: os três participantes são estudantes de Engenharia de Software da mesma faculdade — amostra homogênea e tecnicamente fluente. Problemas que afetam idosos, pessoas com baixa literacia digital ou baixa visão podem não ter sido detectados. Os resultados são **indicativos do fluxo**, não conclusivos sobre toda a base de usuários do Sabin. Não foi possível incluir, nesta rodada, um participante com deficiência (recomendação opcional da metodologia) — registrado como oportunidade para a próxima rodada.

3. Roteiro de Tarefas

Foram redigidas **três tarefas representativas**, formuladas como **cenários de uso** (e não como instruções literais da interface), todas **sem necessidade de login** e em páginas/fluxos distintos do site.

TAREFA 1 — AGENDAMENTO DE EXAME

"Agende um exame de **hemograma completo** na unidade **Ceilândia Centro**."

Sucesso: chegar a uma tela do fluxo de agendamento com o exame e a unidade corretos selecionados. **Falha notável:** não localizar o exame/unidade ou cair em erro 404.

TAREFA 2 — AGENDAMENTO DE VACINA (DEPENDENTE)

"Você quer agendar uma vacina de **febre amarela** no site, para o seu **filho de 9 meses**, na unidade **Águas Claras**."

Sucesso: chegar ao fluxo com a vacina e a unidade selecionados. **Observar:** se o site comunica claramente a restrição de idade (9 meses).

TAREFA 3 — BUSCA DE INFORMAÇÃO

"Você quer ver as **orientações de preparo** para um agendamento de **check-up executivo**."

Sucesso: chegar à página do check-up executivo e indicar verbalmente as orientações de preparo.

Antes do teste, a equipe mapeou hipóteses de fricção para cada fluxo (storyboards), a serem confirmadas ou refutadas pelas sessões reais:



Figura 1. Storyboard de hipóteses de fricção da Tarefa 1 (agendamento de hemograma) — previsão a ser validada pelas sessões.

4. Procedimento, Ambiente e Ética (TCLE)

Cada sessão (duração real: P1 — 6 min 55 s · P2 — 6 min 35 s · P3 — 10 min 22 s; média ≈ 8 min) seguiu um roteiro padronizado: boas-vindas e contextualização, tarefa de aquecimento, execução das tarefas com **verbalização em voz alta**, perguntas abertas pós-tarefa e questionário SUS. O avaliador **não auxiliava** durante as tarefas (salvo intervenção registrada após travamento prolongado) e respondia a pedidos de ajuda com "O que você tentaria fazer?".

Item	Especificação
Modalidade	Presencial, em ambiente controlado e silencioso
Gravação	Tela + áudio, mediante consentimento (TCLE assinado antes do início)
Cronometragem	Início na leitura completa da tarefa; fim na declaração do participante ou timeout de 5 min
Desfecho registrado	Sucesso completo / sucesso parcial (com ajuda) / falha
Anotações de campo	Hesitações, erros, cliques e comentários espontâneos
Navegador	Google Chrome atualizado, sem histórico/login do site, 1366×768

Ética: foi aplicado um **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)** contendo objetivo da pesquisa, procedimentos, aviso de gravação de tela/áudio, garantia de anonimato (identificação apenas como "P1"... "P3"), direito de desistência a qualquer momento e contato dos pesquisadores. As gravações são confidenciais, de uso acadêmico, e serão excluídas após a entrega final. *(TCLE na íntegra — ver Anexo A.)*

5. Métricas de Usabilidade

As três métricas quantitativas exigidas — **taxa de sucesso (eficácia)**, **tempo médio na tarefa (eficiência)** e **número de erros** — foram coletadas por sessão. A taxa de sucesso pondera: sucesso sem ajuda = 1,0; sucesso com ajuda = 0,5; falha = 0.

5.1 Resumo por participante e tarefa

Part.	T1 (hemograma)	T2 (vacina)	T3 (preparo)	Erros/desvios notáveis
P1	Sem ajuda · 240 s	—	—	Explorou várias abas informativas antes de achar o caminho
P2	Sem ajuda · 195 s	—	—	Caiu no atendimento móvel; usou "voltar" do navegador e perdeu a busca
P3	Com ajuda · 285 s	Com ajuda · 190 s	Sem ajuda · 45 s	Múltiplos caminhos errados; 2 dicas na T1, 1 dica na T2

Cobertura parcial: T1 foi aplicada aos 3 participantes; T2 e T3, apenas a P3 — por dificuldade de conciliar agenda com P1 e P2. As médias abaixo deixam o escopo explícito.

5.2 Métricas calculadas

Métrica	Tarefa 1 (n=3)	Tarefa 2 (n=1)	Tarefa 3 (n=1)
Taxa de sucesso (eficácia)	83,3% $(1,0 + 1,0 + 0,5)/3$	50% (com ajuda)	100% (sem ajuda)
Tempo médio (eficiência)	240 s $(240 \cdot 195 \cdot 285)$	190 s	45 s
Conclusão sem ajuda	2 de 3	0 de 1	1 de 1
Erros/desvios	Alto (todos exploraram caminhos errados)	Alto (sobrecarga de informação)	Nenhum relevante

A leitura cruzada é reveladora: a tarefa de **busca de informação (T3)** teve **100% de eficácia e 45 s**, enquanto as tarefas de **agendamento (T1/T2)** exigiram muito mais tempo e ajuda. O gargalo está claramente no **fluxo de agendamento**.

6. Escore SUS (System Usability Scale)

Ao final das tarefas, cada participante preencheu o questionário SUS (10 itens, escala 1–5), de forma independente. As respostas foram **tabuladas item a item** (planilha `tabulacao_sus.xlsx`). O escore varia de 0 a 100; valores abaixo de 50 são considerados de usabilidade **inaceitável**.

Participante	Escore SUS	Classificação
P1	42,5	Inaceitável (<50)
P2	37,5	Inaceitável (<50)
P3	32,5	Inaceitável (<50)
Média (n=3)	37,5	Inaceitável (<50)

Os **três participantes** ficaram abaixo de 50 (faixa "Inaceitável") — nenhum alcançou sequer a faixa "Mediana" (50–68), o que reforça a gravidade dos problemas do fluxo de agendamento.

6.1 Tabulação item a item (n=3)

Respostas na escala 1–5 (1 = discordo totalmente; 5 = concordo totalmente). Itens ímpares são afirmações positivas; pares, negativas.

#	Afirmação (SUS)	P1	P2	P3
1	Gostaria de usar o site com frequência	3	1	1
2	Site desnecessariamente complexo	4	4	4
3	Site fácil de usar	2	2	2
4	Precisaria de suporte de pessoa técnica	2	1	2
5	Funções bem integradas	2	2	2
6	Muita inconsistência no site	4	3	4
7	Maioria aprenderia a usar rapidamente	3	1	2
8	Site muito difícil de usar	3	4	4
9	Senti-me confiante usando o site	2	2	2
10	Precisei aprender muita coisa antes de usar	2	1	2
	Escore SUS	42,5	37,5	32,5

6.2 Detalhe do cálculo

Ímpares: soma das respostas – 5 · Pares: 25 – soma das respostas · Total × 2,5.

Part.	Ímpares (1,3,5,7,9)	Pares (2,4,6,8,10)	Total × 2,5	Escore
P1	$(3+2+2+3+2) - 5 = 7$	$25 - (4+2+4+3+2) = 10$	$(7 + 10) \times 2,5$	42,5
P2	$(1+2+2+1+2) - 5 = 3$	$25 - (4+1+3+4+1) = 12$	$(3 + 12) \times 2,5$	37,5

P3	$(1+2+2+2+2) - 5 = 4$	$25 - (4+2+4+4+2) = 9$	$(4 + 9) \times 2,5$	32,5
----	-----------------------	------------------------	----------------------	-------------

Os itens de maior penalização, **comuns aos três participantes**, foram o item 2 ("site desnecessariamente complexo", 4 em todos), o item 8 ("muito difícil de usar", 3·4·4) e o item 6 ("muita inconsistência", 4·3·4) — coerentes com a confusão de taxonomia e o redirecionamento sem aviso observados nas tarefas de agendamento.

7. Achados de Usabilidade

Os problemas abaixo emergiram de forma recorrente entre os participantes, com severidade na mesma escala da avaliação heurística para permitir comparação.

ID	Problema observado	Severidade	Heurística
TU-01	Nomenclatura ambígua. "Compra online" não é reconhecida como "agendar exame". Os participantes vasculharam abas informativas ("Exames laboratoriais", "Serviços digitais", "Atendimento domiciliar") antes de achar o caminho correto.	Crítico	H2 — Mundo real
TU-02	Desvio sem aviso e sem saída. O botão "Agendar exame" no resultado da busca leva ao atendimento móvel/domiciliar; sem botão "voltar" no site, o usuário recorre ao navegador e perde a busca.	Alto	H3 / H5
TU-03	Ausência de etapa de data/horário. Nenhum participante encontrou onde escolher data — frustração explícita ao final do fluxo.	Crítico	H1 — Status

Citações dos participantes (Think Aloud)

"Achei os termos um pouco confusos... a primeira opção é agendar exame, mas ele vai para um local que não faz sentido, que é o atendimento domiciliar. A opção certa é comprar exame..." — **P2**

"Tô procurando onde que eu vou agendar um exame... Acho que não é aqui, né? Não tô achando." / "Ah, tá. Então eu tenho que comprar meu exame aqui primeiro?" — **P3**

"Foi bem mais fácil e mais intuitivo de encontrar as orientações." — **P3, sobre a Tarefa 3**

Relação com o achado catastrófico do site: a Tarefa 1 está diretamente ligada à rota de agendamento, que — em inspeção técnica — retorna erro 404 quando acessada por `/agendamento/`, reforçando a fragilidade do fluxo central:

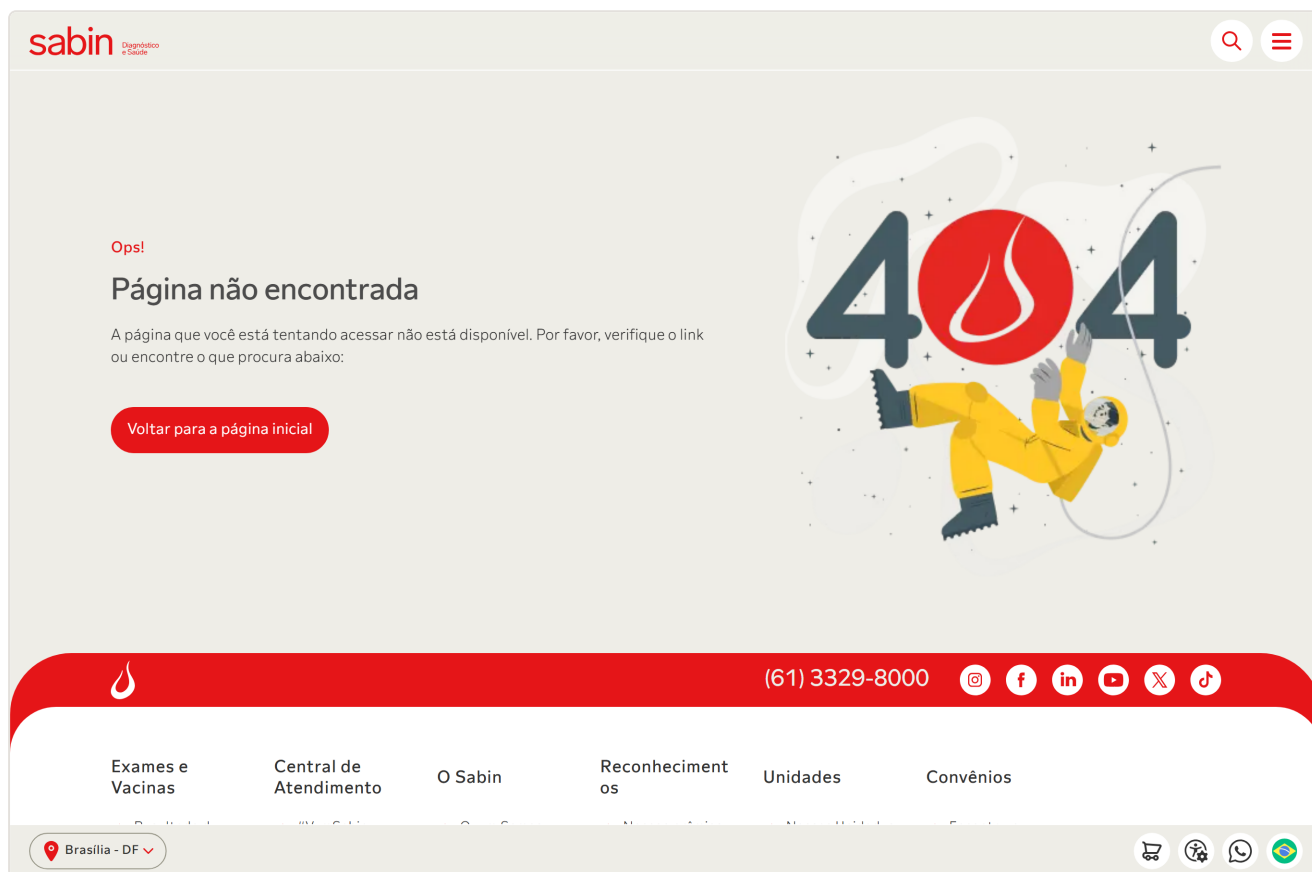


Figura 2. A rota `sabin.com.br/agendamento/` retorna erro 404 — o fluxo que os participantes tentavam concluir é, na prática, frágil e inconsistente.

8. Achados de Acessibilidade (WCAG 2.2)

Embora a rodada não tenha incluído participante com deficiência, as tarefas tocaram em elementos que impactam diretamente a acessibilidade. Os achados WCAG mais relevantes para essas jornadas (detalhados na avaliação de acessibilidade do grupo) são:

Critério WCAG 2.2	Constatação no fluxo testado	Status
1.3.1 / 2.4.2 — Títulos e semântica (A)	Homepage sem <code><h1></code> (confirmado ao vivo): usuário de leitor de tela não identifica o título da página de partida das tarefas.	Não Conforme
2.4.1 — Skip links (A)	Nenhum link "pular para o conteúdo": navegação por teclado tabula por todo o menu antes de chegar ao conteúdo.	Não Conforme
2.4.7 — Foco visível (AA)	Ausência de <code>:focus-visible</code> : a posição do teclado fica imperceptível nos botões dos fluxos de agendamento.	Não Conforme
3.3.1 — Identificação de erros (A)	Portal de resultados sem <code><label></code> nem orientação de formato da credencial.	Não Conforme
1.4.3 — Contraste (AA)	Textos de apoio em #999 (~2,85:1) abaixo do mínimo de 4,5:1.	Não Conforme

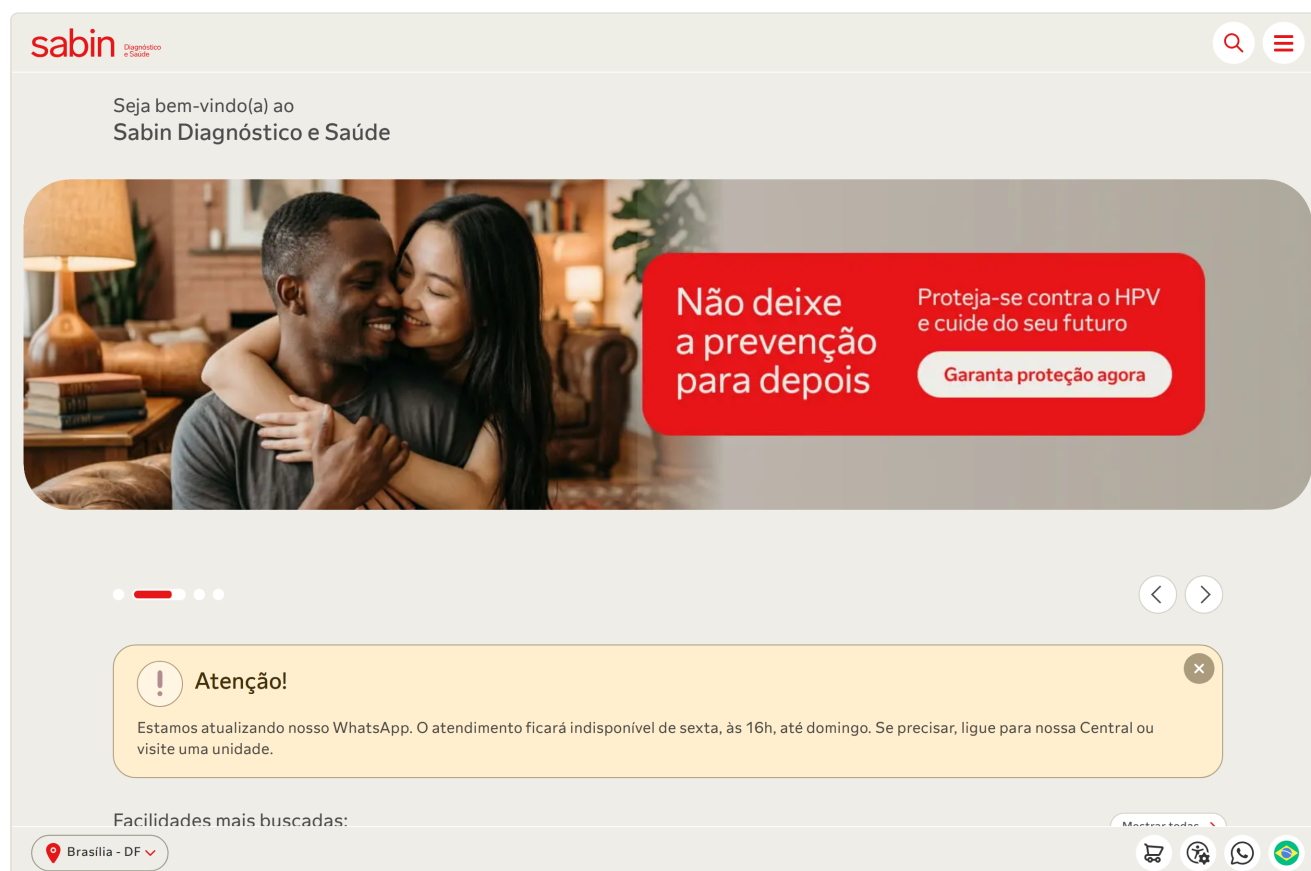


Figura 3. Página de partida das tarefas: o primeiro cabeçalho é um `<h2>` — não há `<h1>`, prejudicando a orientação por leitor de tela.

Para um usuário com deficiência visual, a combinação desses fatores tornaria as tarefas de agendamento — já difíceis para usuários videntes fluentes — possivelmente inviáveis sem assistência.

9. Recomendações Priorizadas

Prioridade	Ação recomendada	Resolve
Imediata	Renomear "Compra online" para " Agendar exame " de forma consistente em todos os pontos de contato.	TU-01
Imediata	Corrigir a rota /agendamento/ (404) e garantir um caminho único e óbvio para o agendamento.	TU-01, fluxo central
Imediata	Incluir etapa explícita de seleção de data e horário antes da confirmação.	TU-03
Alta	Ao acionar "Agendar", oferecer escolha clara (Unidade física × Domiciliar) em vez de redirecionar sem aviso; adicionar botão "voltar" interno.	TU-02
Alta	Adicionar <h1> , skip link e :focus-visible ; corrigir contraste dos textos de apoio.	Acessibilidade (WCAG A/AA)
Média	Reduzir a sobrecarga de informação na listagem de vacinas e adicionar busca interna.	T2 — "muita informação"

10. Reflexão Final

O teste confirmou empiricamente o que a inspeção especialista previa: o portal Sabin **cumpre bem as tarefas de informação, mas falha nas tarefas de ação** (agendamento). O dado mais eloquente é o contraste interno da própria sessão de P3 — perdida e dependente de ajuda nas tarefas de agendamento (T1/T2), porém rápida e confiante na busca de preparo (T3). Isso isola o problema: não é o site inteiro que é ruim, é o **modelo conceitual do agendamento** que está desalinhado da expectativa do usuário.

Do ponto de vista de aprendizado, a rodada evidenciou o valor do Think Aloud: métricas isoladas (a T1 teve 83% de eficácia) podem mascarar uma experiência ruim, mas as verbalizações ("então eu tenho que comprar meu exame primeiro?") expõem o atrito cognitivo real. O SUS médio de 37,5 traduz numericamente essa insatisfação.

As **principais limitações** a corrigir em rodadas futuras são: (1) a **amostra homogênea** de estudantes de tecnologia, que não representa o público diverso do Sabin; (2) a **cobertura parcial** de tarefas (T2/T3 apenas com P3); e (3) a **ausência de um participante com deficiência** — recomendação opcional da metodologia que, se cumprida, tornaria os achados de acessibilidade empíricos, e não apenas inspecionais. Ainda assim, mesmo uma amostra pequena e fluente foi suficiente para revelar problemas críticos — o que reforça, na prática, a tese de Nielsen de que poucos usuários já expõem a maioria dos problemas graves de usabilidade.

11. Referências

- BROOKE, John. SUS: A "Quick and Dirty" Usability Scale. In: JORDAN, P. W. et al. (eds.). *Usability Evaluation in Industry*. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.
- ERICSSON, K. A.; SIMON, H. A. *Protocol Analysis: Verbal Reports as Data*. Cambridge: MIT Press, 1993.
- KRUG, Steve. *Não Me Faça Pensar: Uma Abordagem de Bom Senso à Usabilidade Web e Mobile*. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.
- NIELSEN, Jakob. *Usability Engineering*. San Diego: Academic Press, 1993.
- RUBIN, Jeffrey; CHISNELL, Dana. *Handbook of Usability Testing*. 2. ed. Indianapolis: Wiley, 2008.
- W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.

12. Anexos

Anexo A — Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Antes de cada sessão, o participante leu e assinou um **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)** contendo: objetivo da pesquisa; procedimentos (3 tarefas, ~20–30 min, *Think Aloud*); aviso de gravação de tela e áudio; garantia de **anonimato** (identificação apenas como "P1"... "P3"); direito de desistência sem penalidade; e contato dos pesquisadores responsáveis (Equipe IHC 2026.1 — Grupo 07, UnB). As vias assinadas ficam sob guarda do grupo, exclusivamente como comprovação do consentimento.

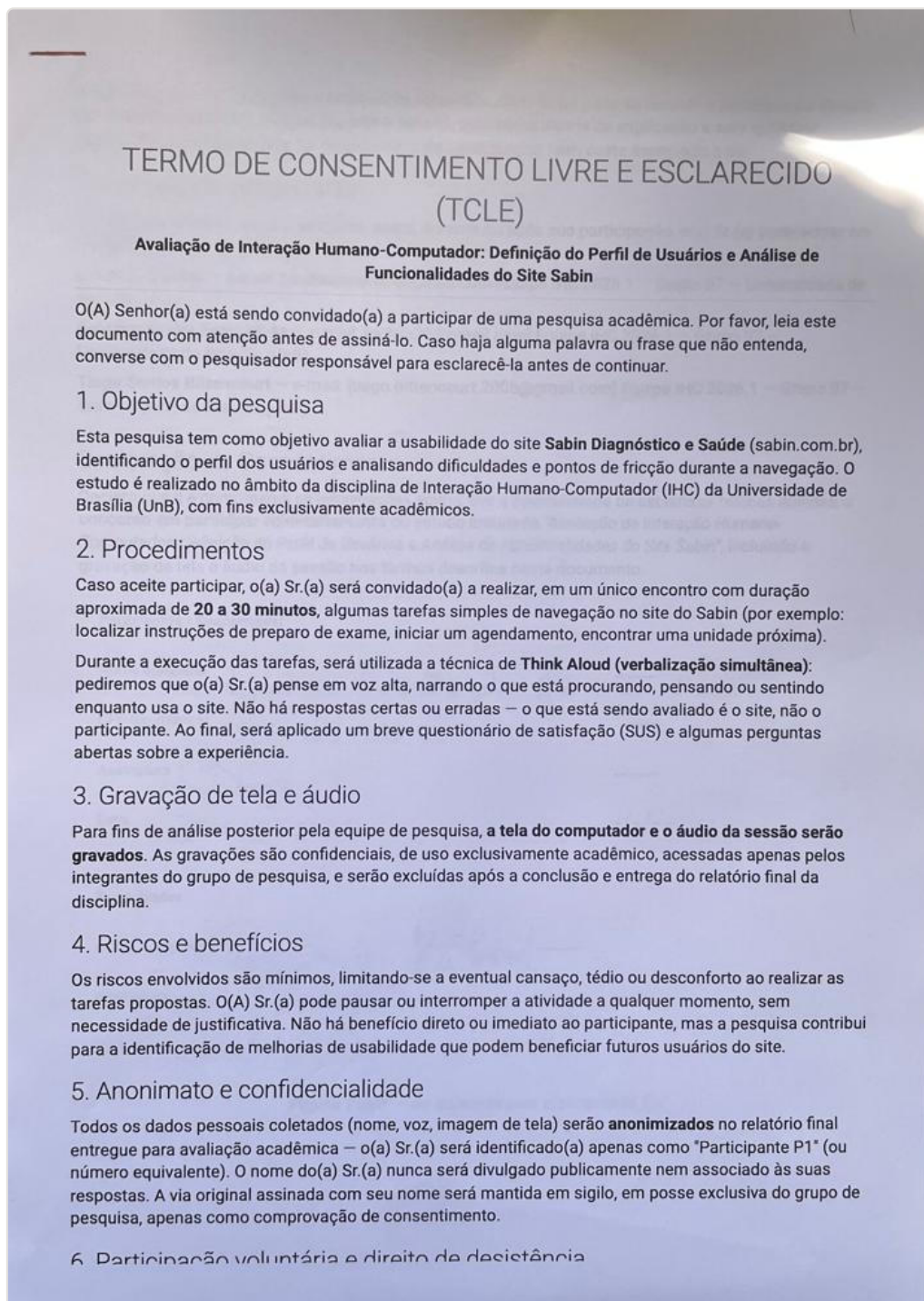


Figura 4. TCLE — frente (texto do termo): objetivo da pesquisa, procedimentos, gravação de tela/áudio, riscos/benefícios e a cláusula de anonimato e confidencialidade.

A participação nesta pesquisa é **totalmente voluntária**. O(A) Sr.(a) pode se recusar a participar ou desistir em qualquer momento, mesmo durante a sessão, sem necessidade de explicação e **sem qualquer penalidade ou prejuízo**. Não há pagamento pela participação, nem custo associado a ela.

7. Contato do pesquisador

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, antes, durante ou após sua participação, o(a) Sr.(a) pode entrar em contato com:

Lucas A. Zanetti — e-mail: landradezanetti@gmail.com Equipe IHC 2026.1 — Grupo 07 — Universidade de Brasília (UnB)

Gustavo Xavier Evangelista — e-mail: [guhxe32@gmail.com] Equipe IHC 2026.1 — Grupo 07 — Universidade de Brasília (UnB)

Tiago Santos Bittencourt — e-mail: [tiago.bittencourt.2005@gmail.com] Equipe IHC 2026.1 — Grupo 07 — Universidade de Brasília (UnB)

Declaração de Consentimento

Declaro que li e compreendi as informações acima, tive a oportunidade de esclarecer minhas dúvidas, e **concordo em participar voluntariamente** do estudo intitulado *"Avaliação de Interação Humano-Computador: Definição do Perfil de Usuários e Análise de Funcionalidades do Site Sabin"*, incluindo a gravação de tela e áudio da sessão nos termos descritos neste documento.

Participante / Responsável	
Nome completo	anonimizado (LGPD)
CPF (ou RG)	anonimizado (LGPD)
Assinatura	anonimizado (LGPD)
Data	25/06/2026 -/-

Pesquisador	
Nome completo	anonimizado (LGPD)
Assinatura	anonimizado (LGPD)
Data	25/06/2026 -/-

Página 1 de 1 — via impressa para assinatura física

Figura 5. TCLE — verso (participação voluntária, contato dos pesquisadores e Declaração de Consentimento assinada). Nome completo, CPF e assinaturas foram **tarjados** para preservar o anonimato prometido no próprio termo e atender à LGPD; permanecem visíveis os rótulos dos campos e a data de coleta (25/06/2026), comprovando o consentimento.

Anexo B — Tabulação completa das métricas por tarefa

Detalhamento qualitativo e quantitativo de cada execução observada (fonte: planilha `tabulacao_metricas.xlsx`). A T1 foi aplicada aos 3 participantes; T2 e T3, apenas a P3.

P1 · T1 — Hemograma Sem ajuda · ⌚ 240 s · seleção do item ✓ · unidade ✓

CAMINHO PERCORRIDO

Menu > Exames laboratoriais > Preparo de exames > Serviços digitais > Unidades > Compra online > Busca > Comprar > Nossas unidades > Ceilândia Centro

ERROS E DESVIOS

Procurou o agendamento em abas informativas antes de ir para "Compra online".

VERBALIZAÇÃO MARCANTE

"Eu achei bem complicado. Os nomes não eram o que eu estava esperando... Eu senti falta também na questão da data."

OBSERVAÇÃO DO AVALIADOR

Explorou grande parte do menu principal tentando achar a opção correta — a taxonomia do menu não está alinhada ao modelo mental.

P2 · T1 — Hemograma Sem ajuda · ⌚ 195 s · seleção do item ✓ · unidade ✓

CAMINHO PERCORRIDO

Página inicial > Menu principal > Abas informativas > Busca > "Agendar o exame" (cai em atendimento móvel) > Voltar do navegador > Comprar online > Ceilândia Centro

ERROS E DESVIOS

Clicou em "Agendar o exame" e foi para atendimento domiciliar; não encontrou botão "voltar" no site.

VERBALIZAÇÃO MARCANTE

"Achei os termos um pouco confusos... a primeira opção é agendar exame, mas ele vai para um local que não faz sentido... Senti falta de data."

OBSERVAÇÃO DO AVALIADOR

Evidenciou um problema grave de taxonomia — "comprar" não é associado a "agendar".

P3 · T1 — Hemograma Com ajuda · ⌚ 285 s · 2 dicas · seleção do item ✓ · unidade ✓

CAMINHO PERCORRIDO

Botão agendamento > Pré-cadastro > Solicitação de exames > Conteúdo de apoio > Serviços digitais > Agilizar exames > Menu (1ª dica) > Compre online (2ª dica) > Busca > Comprar exame

ERROS E DESVIOS

Procurou o agendamento em várias telas antes do caminho correto; só chegou ao fluxo certo após duas dicas do avaliador.

VERBALIZAÇÃO MARCANTE

"Vou apertar no botão de agendamento, que faz sentido... Acho que não é aqui, né, mano? Não tô achando... Então eu tenho que comprar meu exame aqui primeiro."

OBSERVAÇÃO DO AVALIADOR

Participante visivelmente perdida — reforça nomenclaturas confusas e o redirecionamento-surpresa.

P3 · T2 — Vacina de febre amarela **Com ajuda** · ⌚ 190 s · 1 dica · item ✓ · unidade ✓ · restrição de idade: não relatada pelo site

CAMINHO PERCORRIDO

Menu › Vacinas › Agendar na unidade › Águas Claras › Tela da unidade › Compre online › Menu (*dica*) › Vacinas infantis (9 meses) › Vacina de febre amarela › Águas Claras

ERROS E DESVIOS

Tentou agendar pela página da unidade e pelo "Compre online" antes de achar o caminho por "Vacinas infantis", com a ajuda do avaliador.

VERBALIZAÇÃO MARCANTE

"Meu Deus, muita informação. Eu queria pesquisar a vacina de febre amarela, mas não sei como faz isso. Vou clicar em vacinas infantis porque meu filho tem 9 meses."

OBSERVAÇÃO DO AVALIADOR

O mesmo problema de taxonomia da T1 se repete no fluxo de vacinas.

P3 · T3 — Orientação de preparo (check-up executivo) **Sem ajuda** · ⌚ 45 s · item ✓ · unidade ✓

CAMINHO PERCORRIDO

Menu › Exames › Check-up executivo › rola a página › Orientações de preparo

ERROS E DESVIOS

Nenhum desvio relevante — caminho direto pelo menu.

VERBALIZAÇÃO MARCANTE

"Tô descendo a tela aqui para achar a orientação. Orientações de preparo. Achei."

OBSERVAÇÃO DO AVALIADOR

Bem mais fácil e intuitivo de encontrar as orientações — contraste claro com o fluxo de agendamento.

Anexo C — Artefatos e gravações

Artefato	Endereço
Planejamento do teste	unb-ihc.github.io/IHC_2026.1_Grupo07/ihc-sabin/teste-usabilidade/planejamento/
Persona do participante	unb-ihc.github.io/IHC_2026.1_Grupo07/ihc-sabin/teste-usabilidade/persona/
Roteiro de tarefas	unb-ihc.github.io/IHC_2026.1_Grupo07/ihc-sabin/teste-usabilidade/roteiro/
Questionário SUS	unb-ihc.github.io/IHC_2026.1_Grupo07/ihc-sabin/teste-usabilidade/questionario-sus/
Tabulação de métricas (planilha)	relatorio-teste-usabilidade/img/tabulacao_metricas.xlsx
Tabulação do SUS (planilha)	relatorio-teste-usabilidade/img/tabulacao_sus.xlsx
TCLE	unb-ihc.github.io/IHC_2026.1_Grupo07/ihc-sabin/teste-usabilidade/tcle/
Resultados completos (3 sessões + vídeos)	unb-ihc.github.io/IHC_2026.1_Grupo07/ihc-sabin/teste-usabilidade/resultados/

Gravações das sessões (P1, P2, P3) disponíveis de forma anonimizada no YouTube, vinculadas na página de resultados. Evidências de site capturadas em 26/06/2026.